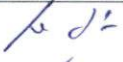


วิธีปฏิบัติ (Work instruction)

ชื่อเอกสารเรื่อง : การทำแผล

รหัสเอกสารER 05.....

ผู้จัดทำ..... <u>นิพนิต คุ้มเมือง</u> (<u>นส. นิพนิต คุ้มเมือง</u>) ตำแหน่ง..... <u>พยาบาลวิชาชีพ ปริญญาตรี</u>	วันที่จัดทำ..... <u>30 มิถุนายน 63</u>
ผู้ทบทวน..... <u>นางพิชญนันท์ สาละพันธ์</u> (.....) <u>นางพิชญนันท์ สาละพันธ์</u> ตำแหน่ง..... <u>พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ</u>	วันที่ทบทวน.....
ผู้อนุมัติ..... <u>นางสาวนพพร มุลวงษ์</u> (.....) <u>นางสาวนพพร มุลวงษ์</u> ตำแหน่ง..... <u>หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล</u>	วันที่อนุมัติ.....
สำเนาฉบับที่.....	ผู้ถือครอง.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....
แก้ไขครั้งที่.....	วันที่เริ่มใช้.....

	โรงพยาบาลบ้านตาก BANTAK HOSPITAL	หน้า 1/1
วิธีปฏิบัติ (Work instruction)	ฉบับที่ :ER 05	เลขที่ : 5
เรื่อง : การทำแผล		วันที่ : 30 มกราคม 2563
หน่วยงาน : งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	
ผู้เรียบเรียง : นางสาวปิยะนัต คงเมือง ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ		ผู้อนุมัติ :  ตำแหน่ง : (นางสาวเทพทวย มุลวงษ์) หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผล
2. เพื่อป้องกันไม่ให้แผลได้รับอันตราย
3. ช่วยกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้น
4. เพื่อชะล้างวัตถุต่างๆที่ตกค้างในแผล
5. เพื่อดูซับสิ่งที่ไหลออกจากแผล
6. เพื่อห้ามเลือด
7. เพื่อป้องกันผิวนรอบๆแผลที่มีต่อระคายเคืองและลอกหลุดออกมา
8. เพื่อช่วยยึดหรือพยุงแผล
9. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสบาย

นโยบาย

การทำแผลของเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์

1. setทำแผลsterile
 - ประกอบด้วย
 - 1.1 ผ้าห่อชุดทำแผล
 - 1.2 ถาด 1 ใบ สำหรับบรรจุอุปกรณ์ทุกอย่าง
 - 1.3 ถ้วยใส่น้ำยา 2 ใบ

	โรงพยาบาลบ้านตาก BANTAK HOSPITAL	หน้า 1/ 2
วิธีปฏิบัติ (Work instruction)	ฉบับที่ : ER 05	เลขที่ : 5
เรื่อง : การทำแผล		วันที่ : 30 มกราคม 2563

- 1.4 ปากคีบชนิดมีเขี้ยว 1 อัน
- 1.5 ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยว 1 อัน
- 1.6 สำลี
- 1.7 ผ้าก๊อซ
2. น้ำยาต่างๆที่ใช้ทำแผลเช่น 0.9% NSS, Povidine
3. กระปุกและcleansing forcep
4. ภาชนะสำหรับใส่ขยะ หรือตะแกรงชะล้างแผล
5. ถุงมือปราศจากเชื้อ
6. พลาสเตอร์ปิดแผล
7. อุปกรณ์ที่อาจต้องเพิ่ม
 - 7.1 สำลี หรือผ้าก๊อซ เพิ่มกรณีมีแผลขนาดใหญ่
 - 7.2 ถุงมือsterile ใช้แทนปากคีบ (กรณีแผลขนาดใหญ่มากหรือแผล Burn) หรือถ้าผ้าปิดแผลสกปรกมาก ควรสวมถุงมือหยาบ
 - 7.3 ผ้าพัน (Bandage) ในผู้ป่วยที่มีแผลขนาดใหญ่มาก หรือผู้ป่วยถูกไฟไหม้ หรือผู้ป่วยที่แพ้ พลาสเตอร์
 - 7.4 Gauze Drain

วิธีปฏิบัติ

การทำแผลชนิดแห้ง (Dry dressing)

1. เปิดแผลและประเมินชนิดของแผล ขนาด จำนวนสิ่งที่ไหลออกจากแผล
2. ล้างมือให้สะอาด
3. เตรียมชุดทำความสะอาดแผลด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ แล้วปิดชุดทำแผลไว้ ได้แก่
 - 3.1. ถาดสำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด

	โรงพยาบาลบ้านตาก BANTAK HOSPITAL	หน้า 1/ 3
วิธีปฏิบัติ (Work instruction)	ฉบับที่ : ER 05	เลขที่ : 5
เรื่อง : การทำแผล		วันที่ : 30 มกราคม 2563

3.2.ชุดทำแผลปราศจากเชื้อโรค ซึ่งประกอบด้วย ปากคีบสัน 2 อัน ถ้วยใส่น้ำยา สำลีและผ้าก๊อสดตามขนาดหรือสิ่งระบายจากแผล

3.3.เหล็มน้ำยา 0.9% NSS และ Povidine

วางชุดทำแผลไว้ใกล้บริเวณแผล เช่น บนรถทำแผล โต๊ะข้างเตียง หรือโต๊ะเครื่องมือเตียง ควรเป็นตำแหน่งที่ผู้ทำไม่เอื้อมข้ามชุดทำแผลขณะทำแผล จากนั้นให้เปิดชุดทำแผลด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ

4. บอกให้ผู้ป่วยทราบว่า จะทำแผลให้รวมทั้งอธิบายสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการทราบเกี่ยวกับการทำแผล โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน
5. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น กันม่าน ปิดประตูห้อง ปิดพัดลม
6. จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่เหมาะสม เปิดเฉพาะตำแหน่งที่มีแผล
7. ล้างมือ
8. ใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ
9. ใช้ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยวคีบสำลีชุบน้ำยา 0.9 NSS ปิดพองพองโดยให้ปากคีบมีเขี้ยวอยู่ล่างเสมอ แล้วส่งให้ปากคีบมีเขี้ยวคีบสำลีรอบแผลจากในออกนอก เป็นวงกว้างจนสะอาด (รัศมีประมาณ 1-2 นิ้ว) ถ้าแผลที่มีสิ่งระบายต่าง ๆ ติดที่แผล ใช้สำลีชุบน้ำเกลือ 0.9 % เช็ดออกให้สะอาดโดย เริ่มเช็ดจากส่วนในของแผลก่อน แล้วจึงเช็ดผิวหนัง รอบ ๆ แผลเป็นวงกว้าง
10. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อสให้ปิดเลยแผลโดยรอบประมาณ 1 นิ้ว และปิดพลาสติกตามแนวขวางลำตัวหรือใช้ผ้าพันแผลพัน
11. ถ้าแผลที่มีท่อระบาย (Drain) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ควรทำความสะอาดแผลผ่าตัดให้เสร็จก่อน แล้วจึงทำแผลที่มีท่อระบาย ปิดแผลด้วยผ้าแต่งแผล โดยแยกผ้าปิดแผลแต่ละแผลออกจากกัน
12. เก็บเครื่องมือต่าง ๆ ให้ครบ นำไปทำความสะอาดอย่างถูกวิธี และเก็บเข้าที่
13. ล้างมือ บันทึก ลักษณะของบาดแผลลงในบันทึกทางการพยาบาลเกี่ยวกับสิ่งที่ออกจากแผลจำนวน สี และกลิ่น อาการผิดปกติต่าง ๆ ที่พบ

การทำแผลชนิดเปียก (Wet dressing)

1. เปิดแผลและประเมินชนิดของแผล ขนาด จำนวนสิ่งที่ไหลออกจากแผล
2. ล้างมือให้สะอาด
3. เตรียมชุดทำความสะอาดแผลด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ แล้วปิดชุดทำแผลไว้ได้แก่

	โรงพยาบาลบ้านตาก BANTAK HOSPITAL	หน้า 1/1
วิธีปฏิบัติ (Work instruction)	ฉบับที่ : ER 05	เลขที่ : 5
เรื่อง : การทำแผล		วันที่ : 30 มกราคม 2563

- 3.1. ถาดสำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
 - 3.2. ชุดทำแผลปราศจากเชื้อโรค ซึ่งประกอบด้วย ปากคีบสัน 2 อัน ถ้วยใส่น้ำยา สำลีและผ้าก๊อสดตามขนาดหรือสิ่งระบายจากแผล
 - 3.3. เหน็บยา 0.9% NSS และ Povidine
- วางชุดทำแผลไว้ใกล้บริเวณแผล เช่น บนรถทำแผล โต๊ะข้างเตียง หรือโต๊ะคร่อมเตียง ควรเป็นตำแหน่งที่ผู้ทำไม่เอื้อมือข้ามชุดทำแผลขณะทำแผล จากนั้นให้เปิดชุดทำแผลด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ
4. บอกให้ผู้ป่วยทราบว่า จะทำแผลให้รวมทั้งอธิบายสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการทราบเกี่ยวกับการทำแผล โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน
 5. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น กันม่าน ปิดประตูห้อง ปิดพัดลม
 6. จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าที่เหมาะสม เปิดเฉพาะตำแหน่งที่มีแผล
 7. ล้างมือ
 8. ใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ
 9. ใช้ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยวคีบสำลีชุบน้ำยา 0.9 % NSS บิดพอหมาดโดยให้ปากคีบมีเขี้ยวอยู่ล่างเสมอ แล้วส่งให้ปากคีบมีเขี้ยวเข้รอบแผลจากในออกนอก เป็นวงกว้างจนสะอาด (รัศมีประมาณ 1-2 นิ้ว) ถ้าแผลที่มีสิ่งระบายต่าง ๆ ติดที่แผล ใช้สำลีชุบน้ำเกลือ 0.9 %NSS เช็ดออกให้สะอาดโดย เริ่มเช็ดจากส่วนในของแผลก่อน แล้วจึงเช็ดผิวหนัง รอบ ๆ แผลเป็นวงกว้าง
 10. วาง Gauze ชุบ 0.9 NSS หรือน้ำยาตามคำสั่งแพทย์ไว้ในแผลอย่างหลวม
 11. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อสให้ปิดเลยแผลโดยรอบประมาณ 1 นิ้ว และปิดพลาสติกตามแนวขวางลำตัวหรือใช้ผ้าพันแผลพัน
 12. เก็บเครื่องมือต่าง ๆ ให้ครบ นำไปทำความสะอาดอย่างถูกวิธี และเก็บเข้าที่

	โรงพยาบาลบ้านตาก BANTAK HOSPITAL	หน้า 1/5
วิธีปฏิบัติ (Work instruction)	ฉบับที่ : ER 05	เลขที่ : 5
เรื่อง : การทำแผล		วันที่ : 30 มกราคม 2563

13. ล้างมือ บันทึกลักษณะของบาดแผลลงในบันทึกทางการแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่ออกจากแผลจำนวน สี และกลิ่น อาการผิดปกติต่าง ๆ ที่พบ